

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha, Jose Antonio Rodriguez Garcia.

INTRODUCCIÓN

Una complicación poco conocida, pero potencialmente más peligrosa que el sangrado es la trombocitopenia inducida por Heparina (TIH).

Concepto

La TIH es un síndrome clínico-inmunopatológico que se debe al desarrollo de anticuerpos (generalmente IgG) frente al complejo heparina-Factor 4 plaquetario.

Incidencia

Sólo un 0.5-3% de los pacientes tratados con heparina desarrolla TIH, sin embargo, es uno de los efectos farmacológicos adversos más comunes, debido al volumen total de pacientes que reciben tratamiento con este fármaco.

Aunque se han descrito casos de TIH en pacientes tratados con cualquier tipo de heparina y a cualquier dosis, parece que la incidencia es hasta 10 veces mayor en pacientes tratados con heparina intravenosa; y también en pacientes quirúrgicos.

Clínica

El cuadro típico es el de un paciente que entre el 5º-10º día de tratamiento con heparina presenta una trombocitopenia moderada (en torno a $50 \times 10^9/L$ o descenso relativo de $> 50\%$ respecto a controles previos) y/o fenómenos trombóticos arteriales o venosos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de sospecha lo debemos realizar mediante el Sistema de puntuación de las 4 T, una vez excluidas otras causas de trombocitopenia y comprobada la presencia de anticuerpos anticomplejo heparina-PF4:

PUNTOS	2	1	0
Trombocitopenia	Descenso relativo $>50\%$ o nadir $20-100 \times 10^9/L$	Descenso relativo 30-50% o nadir $10-19 \times 10^9/L$	Descenso relativo $<30\%$ o nadir $<10 \times 10^9/L$
Tiempo exposición heparina-trombocitopenia	5-10 días o ≤ 1 día si exposición a heparina 30 días previos	>10 días o ≤ 1 día si exposición a heparina 30-100 días previos	≤ 1 día (sin exposición reciente a heparina)
Trombosis	Confirmada	Dudosa	No
Otras causas de trombocitopenia	No	Dudosa	Confirmada

Los puntos obtenidos en cada categoría se suman para obtener la probabilidad pretest de TIH: 6-8: alta; 4-5: intermedia; 0-3: baja.

En el caso de que la probabilidad pre-test de TIH sea alta-intermedia, se debe hacer determinación de los niveles de anticuerpos anticomplejo heparina-PF4. Aunque existen diversos tipos de pruebas para la detección de anticuerpos en la TIH, no existe una prueba definitiva con sensibilidad y especificidad del 100%. En los casos de sospecha clínica intermedia o alta se recomienda la realización de prueba serológica dado su alto valor predictivo negativo, si el resultado es negativo, debe hacer pensar en diagnósticos alternativos.

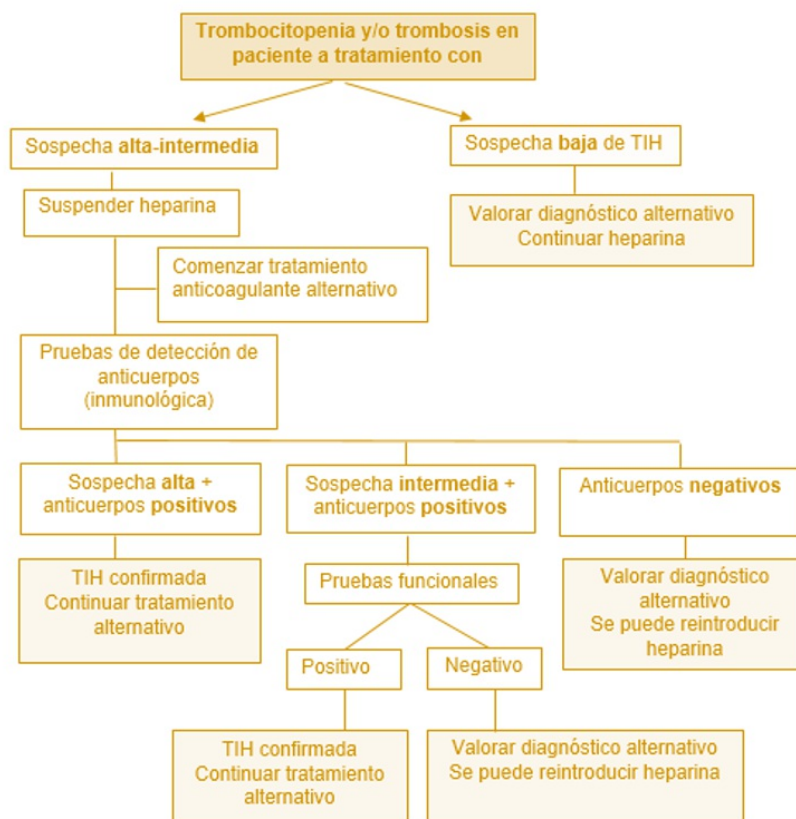


Ilustración 1: Algoritmo diagnóstico y de manejo de la TIH

TRATAMIENTO

- Suspender el tratamiento con HBPM o HNF.
- Tratamiento anticoagulante alternativo a dosis terapéuticas:
 - Fondaparinux: 7.5 mg/día sc
 - Lepirudina 0.10-0.15 mg/kg/h iv
 - Otras opciones: Danaparoides, Argatroban, Abxicimab
 - No dar AVK. No se debe iniciar terapia anticoagulante oral hasta que la cifra de plaquetas sea $>150 \times 10^9/L$
- No transfundir plaquetas.

Nota

- Vigilancia periódica de la cifra de plaquetas en las 2 primeras semanas de tratamiento con heparina.
- Actuar con rapidez ante la simple sospecha diagnóstica.

BIBLIOGRAFÍA.

- Cruz-González I, Sánchez-Ledesma M, Sánchez P et al. Trombocitopenia inducida por heparina. Rev Esp Cardiol. 2007;60:1071-82.
- Cuker A, Crowther M. 2009 Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Heparin-Induced Thrombocytopenia (HIT). Presented by the American Society of Hematology.

